

Celulitis Preseptal y Septal

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David - 2019
Pediatrics 2011
AEP

La clasificación y nomenclatura se basa en la extensión anatómica del proceso infeccioso-inflamatorio en relación al septo orbitario. Esta lámina fibrosa, que se extiende desde el periostio de la órbita hasta los párpados, constituye una barrera protectora que evitaría la extensión de la infección desde las estructuras adyacentes hasta el interior.

Son más frecuentes en la edad pediátrica que en el adulto. La C. Preseptal es más frecuente en niños pequeños, menores de 5 años ya para en la C. Septal la distribución de edad más homogénea, aunque con tendencia a afectar a niños de mayor edad. Existe un predominio de aparición en varones, especialmente en los meses fríos, época en la que aumenta el número de infecciones respiratorias y complicaciones de las mismas.

Etiopatogenia

La CP suele surgir por lesiones de la piel y conjuntiva y la CS como complicación por contigüidad de una sinusitis, la proximidad de los senos paranasales (el seno frontal, seno etmoidal y seno maxilar forman parte constituyente de la órbita) y la existencia de un sistema de drenaje venoso común carente de válvulas para ambas estructuras, facilitan la diseminación hematógica de los microorganismos en caso de infección. La sinusitis etmoidal es el origen más común de la infección orbitaria al estar separado de ésta, únicamente por una estructura porosa.

En niños menores de 36 meses, la CP puede aparecer como un foco secundario a partir de una bacteriemia, especialmente por neumococo y *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib) en la época prevacunal.

Etiología

Los gérmenes más frecuentemente implicados en la actualidad son especies de *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae* (en descenso desde la vacunación), *pyogenes* y *viridans* son las especies más frecuentemente aisladas. En pacientes inmunodeprimidos se han descrito caso de infecciones fúngicas, mucormicosis, de rápida progresión, muy agresivas y, a menudo, fatales.



Niño de 2 años con diagnóstico de celulitis orbitaria. Se observa edema palpebral muy importante y proptosis moderada

Clínica y complicaciones

La clínica se caracteriza por la inflamación de los párpados y, en ocasiones, la presencia de síntomas respiratorios y elevación de la temperatura. La complicación más frecuente es el absceso subperióstico.

Sospecha diagnóstica:

- En la CP, la infección es superficial, por lo que estos pacientes presentan una agudeza visual normal, ausencia de proptosis, movimientos oculares normales y ausencia o dolor leve con los movimientos oculares.
- En la CS, además del edema y eritema palpebral, aparecen edema conjuntival, alteración de los movimientos oculares, proptosis, diplopía y disminución de la agudeza visual.

En ambos casos puede existir fiebre, pero este síntoma es más frecuente en los pacientes con CS.

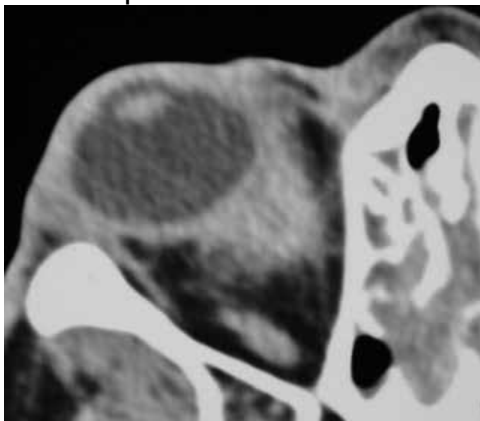
Las complicaciones más frecuentes de la CS en la edad pediátrica son el absceso subperióstico y el absceso orbitario, con frecuencias nada desdeñables.

El absceso subperióstico se define como una colección de pus entre la lámina papirácea y el periostio de la órbita y se considera la complicación más frecuente de la CS. La mayor parte de los abscesos subperiósticos se desarrollan en la pared media de la órbita, como extensión de una sinusitis etmoidal (Fig.). Esta localización se relaciona con una menor necesidad de tratamiento quirúrgico y buena respuesta al tratamiento antibiótico.



Absceso subperióstico en cara medial de la órbita izquierda. Afectación de senos etmoidales.

Los abscesos en otras localizaciones, como la pared superior y lateral de la órbita o los secundarios a sinusitis no etmoidales, se relacionan con mayor necesidad de abordaje quirúrgico y con mayor riesgo de complicaciones (Fig.). Estas últimas localizaciones y sus complicaciones son más frecuentes en niños de mayor edad(13).



Absceso orbitario derecho. Proptosis moderada.

Tabla I. Complicaciones orbitarias de la sinusitis Chandler y cols.

Grupo	Extensión de la enfermedad
Grupo 1	Edema inflamatorio y celulitis preseptal
Grupo 2	Celulitis orbitaria
Grupo 3	Absceso subperióstico
Grupo 4	Absceso orbitario
Grupo 5	Trombosis del seno cavernoso

El retraso en el diagnóstico y en el establecimiento del tratamiento médico o quirúrgico tiene importantes implicaciones para el pronóstico. Pueden producirse complicaciones y secuelas graves oculares, derivadas muchas veces del aumento de la presión intraorbitaria o relacionadas con la extensión local de la infección y vasculitis secundaria que, finalmente, pueden producir lesión del nervio óptico y pérdida de visión. Aunque menos frecuentes, también

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en la clínica aunque, en muchas ocasiones, es preciso realizar una prueba de imagen (TAC) para delimitar la extensión de la enfermedad.

Tabla II. Exploración en los casos de celulitis

Signos y síntomas a valorar

1. Presencia de edema palpebral y si permite la apertura de la hendidura palpebral
2. Afectación conjuntival asociada: hiperemia, edema y secreción
3. Valoración de la agudeza visual de ambos ojos
4. Normalidad o no de los movimientos oculares
5. Normalidad o no de los reflejos pupilares
6. En niños mayores intentar valorar la función del nervio óptico
7. Fondo de ojo
8. Afectación del estado general

Aunque se recomienda realizar un recuento y fórmula y recogida de hemocultivo, estas pruebas tienen un rendimiento muy escaso para establecer el diagnóstico y la extensión del proceso.

La prueba de imagen de elección es la Tomografía craneal con contraste y se debe realizar en proyecciones axiales y coronales.

Criterios para solicitar TAC

- Proptosis
- Oftalmoplejía
- Dolor con los movimientos oculares
- Diplopía
- Pérdida de visión

Posible indicación

- Presencia de neutrofilia >10.000 células/mm³
- Edema que se extienda más allá del borde palpebral
- Signos o síntomas de afectación del SNC
- Imposibilidad de una adecuada valoración del paciente
- Niños menores de un año
- Pacientes que no presentan mejoría tras 24-48 de iniciado el tratamiento

En caso de deterioro del paciente, falta de respuesta al tratamiento o sospecha de sinusitis fúngica o complicación intracraneal, debe considerarse la realización de una RNM.

Tratamiento

En general, la mayor parte de los niños con CP pueden ser manejados de forma ambulatoria, con antibiótico por vía oral y realizándose controles periódicos.

La Academia Americana de Pediatría (AAP) recomienda el manejo ambulatorio de los pacientes con CP leve-moderada (disminución del tamaño de la hendidura palpebral <50%), con Cefalexina, TMS o Clindamicina.

Se debe valorar la observación hospitalaria y el tratamiento intravenoso en niños menores de un año, si la exploración es dificultosa debido al tamaño del edema y en pacientes con afectación del estado general, no correctamente vacunados o inmunodeprimidos. También, se debe considerar el tratamiento intravenoso si existe una mala respuesta al tratamiento oral, tras 24-48 horas de su inicio. La duración del tratamiento se prolonga en general entre 7-10 días.

La celulitis orbitaria requiere el inicio de un rápido tratamiento antibiótico intravenoso con Ceftriaxona con o sin Vancomicina.

Tratamiento adyuvante

Ante sinusitis algunos protocolos incluyen el empleo de descongestionantes tópicos y un estudio reciente sugiere que el uso de corticoides sistémicos puede acelerar la resolución de la inflamación sin exacerbar la infección subyacente.

Otros: analgesia según dolor.

Tratamiento quirúrgico

Uno de los aspectos más debatidos es la necesidad de tratamiento quirúrgico, especialmente en los abscesos subperiósticos, las posibles indicaciones de tratamiento quirúrgico son:

- Absceso mayor de 10 mm.
- Si el absceso no está en localización medial.
- Si hay asociada complicación intracraneal.
- Niños mayores de 9 años (para algunos autores mayores de 6 años).
- Proptosis mayor de 2 mm.
- Presencia de gas en la órbita.
- Infección dental.

Resumen

Celulitis Periorbitaria (preseptal)	Celulitis Orbitaria (septal)
Infección del tejido blando por delante del tabique. Comprende párpados y anexos (órbita, aparato lacrimal y paranasales) 	Infección del tejido blando detrás del tabique. La mayoría es unilateral Estadios: I. Edema inflamatorio II. Celulitis orbitaria III. Absceso subperióstico IV. Absceso orbitario Puede producir infecciones hematógenas.
Epidemiología	
Más frecuente en varones y en menores de 5 años. Secundario a Tx, mordedura, impétigo, orzuelo, dacrositis, absceso dentario	Más frecuente entre los 6m y 2 años. Más frecuente en invierno por su mayor relación con CVAS y sinusitis. Secundario a etmoiditis, sinusitis, acné, lesiones penetrantes, diseminación hematógena.

Etiología	
S. Aerus + fr. S. Pyogenes S. epidermidis Menores de 36 meses: puede aparecer como un foco secundario a partir de una bacteriemia, especialmente por neumococo y Haemophilus influenzae tipo b (Hib), que fue el agente etiológico más frecuentemente implicado en las formas bacteriémicas en la época prevacuna.	
Clínica	
Edema y eritema palpebral Fiebre (menos frecuente que en CO)	Se agrega: Edema conjuntival MEG Ptosis/Quemosis Dolor al movimiento ocular Tb puede tener: Diplopia Disminución de agudeza visual Alteración del reflejo ocular Compromiso del SNC
Signos y síntomas a valorar	
1. Presencia de edema palpebral y si permite la apertura de la hendidura palpebral 2. Afectación conjuntival asociada: hiperemia, edema y secreción 3. Valoración de la agudeza visual de ambos ojos 4. Normalidad o no de los movimientos oculares 5. Normalidad o no de los reflejos pupilares 6. En niños mayores intentar valorar la función del nervio óptico 7. Fondo de ojo 8. Afectación del estado general	
Estudios complementarios	
Analítica Rx de SPN IC oftalmología TAC ante dudas En complicaciones IC a ORL, Infectología y Neurología	Se agrega obligatoriamente la TAC (también es de importancia para realizar diagnóstico diferencial con pseudotumor orbitario)
Tratamiento	
Con puerta de entrada: Cafalexina o TMS o Clindamicina VO	Ceftriaxona + Clindamicina EV 10-14 días, evaluar administrar Vancomicina por Clindamicina (para la cobertura del S. pneumoniae resistente a penicilina y S. Aureus MTR)
Evolución	
Mejoría en 24-48 hs	
Complicaciones	
Recurrencia: 3 o más episodios separados por un mes. Buscar patologías de base como atopía, collagenopatías, neoplasias e infección por VHS, micobacterias atípicas y HIV	Absceso Extensión orbitaria Trombosis del seno cavernoso
Indicaciones generales de TAC	
- Edema palpebral que imposibilita el examen completo - Compromiso del SNC - Deterioro de la agudeza visual o visión cromática - Exoftalmos grosero o oftalmoplejía - Deterioro o falta de mejoría clínica en 24-48 hs postratamiento	